

EXAMEN CLINIQUE DU RACHIS

INSPECTION

- Peau:
 - Tache de café au lait
 - Touffe de poil -> spina bifida
 - Cicatrices -> opération
- Symétrie:
 - Colonne déviée -> scoliose.
Pour identifier la scoliose, demander au patient de se pencher en avant, le dos bien rond. L'examineur observe la régularité du dos
 - Anches (au même niveau? -> jambe plus courte que l'autre): comparer les épine iliaques
 - Fil de plomb: Placer un fil auquel est attaché un poids au niveau de C6-C7 et observer s'il est tendu verticalement.
 - Axe sagittale -> cyphose (vers l'avant) ou lordose (vers l'arrière)
 - Tête



MOBILITÉ

- Cervicale:
 - Flexion antérieure et extension postérieure de la tête
 - Flexions latérales gauche et droite de la tête
 - Rotations droite et gauche de la tête
- Dorsale ou thoracique: pas de mobilité
- Lombaire:

Un examen correcte de la mobilité lombaire exige que le patient ne déplace pas ses hanches. Une compensation à l'aide des membres inférieurs pourrait dissimuler un déficit de mobilité lombaire.

De fait, l'examineur maintient, à l'aide de ses deux mains, les hanches du patient durant tout l'examen.

 - Flexions latérales gauche et droite
 - Flexion et extension
 - Rotations gauche et droite



- Test de Schober:
 - A partir des épinos iliaques. l'examineur rejoint le milieu du tronc, de manière à placer son pouce sur la vertèbre L4.
 - Il descend ensuite son pouce, d'une vertèbre, pour atteindre L5.
 - L'examineur place son index (de la même main) dix centimètres au-dessus.
 - Le patient réalise une flexion en avant durant laquelle l'examineur maintient ses doigts dans les positions initiales (ils suivent le mouvement).
 - L'examineur mesure ensuite la distance séparant ses doigts.
 - Celle-ci doit être supérieure à 14cm (évolution >4cm) dans un contexte physiologique. Si le résultat est inférieur, l'examineur suspecte un arthrose.



- Membre inférieur:
 - Test du nerf sciatique (L5):

- Le patient est couché en décubitus dorsal.
- L'examineur fléchit, passivement, le membre inférieur. Il arrête lorsque le patient signale une douleur.



- L'examineur étend la jambe jusqu'à ce que le patient lui informe que la douleur a disparu.
- Pour s'assurer que le nerf sciatique est bien lésé, l'examineur fléchit le pied du patient. A ce moment-là, le patient doit ressentir une douleur. Attention: L'examineur doit informer du patient qu'il va ressentir une douleur.
- Même méthode avec l'autre jambe.

– Test du nerf fémoral (L2-L3):

- Le patient se couche en décubitus ventral et fléchit la jambe.
- L'examineur soulève la cuisse vers le haut.
- Si le patient ressent une douleur, son nerf fémoral est lésé.
- Même méthode avec l'autre jambe.



– Sautiller:

- Le patient sautille sur chaque jambe.
- Ce test permet de tester les articulations sacro-iliaques. Si le patient ressent une douleur en sautillant, l'examineur envisage une arthrose.

• Tronc vertébral:

– Palpation des muscles paravertébraux:

- L'examineur réalise une palpation symétrique du dos du patient. Il palpe avec ses pouces, de manière symétrique et synchrone, les muscles paravertébraux. Il commence au niveau lombaire et remonte jusqu'au cou.



- L'examineur recherche un muscle qui soit plus tendu que le muscle parallèle. Les douleurs dorsales sont musculaires. On parle de scoliose antalgique lorsque le patient se tord à cause de la douleur musculaire provoquée par la pression.

– Percussion des vertèbres:

- L'examineur percute à l'aide de son poing ou d'un marteau réflexe les vertèbres. Il commence au niveau de la vertèbre C7 et descend jusqu'aux vertèbres lombaires. Il limite les percussions afin d'éviter au patient des douleurs inutiles.
- Si le patient ressent une douleur, l'examineur envisage une ostéoporose.

